

1. 下列有關攝護腺癌 MRI 影像特性的敘述，何者正確？
- A) T2, 攝護腺是 homogeneous 且 zonal anatomy 不容易分辨
 - B) T2, 出血是 high signal
 - C) T2, neuromuscular bundles 在影像上很清楚
 - D) T1, 攝護腺腫瘤是 low signal

Ans: C

Perez and Bradys, Principles and Practice of Radiation Oncology, 7th edition, p4930 (pdf version)

2. 下列有關攝護腺癌已知的 risk factors 何者錯誤？
- A) 亞洲人比斯堪地納維雅人有更低的攝護腺癌機率
 - B) 飲食中的脂肪含量與攝護腺癌發生風險為正相關
 - C) 雄性素與攝護腺癌發生風險相關性沒有定論
 - D) 良性攝護腺肥大與攝護腺癌發生風險為正相關

Ans: D

Perez and Bradys, Principles and Practice of Radiation Oncology, 7th edition, p4872 (pdf version)

3. 有關攝護腺癌，下列基因何者與 increase susceptibility at early age 無關？
- A) RNASEL/HPC1
 - B) BRCA2
 - C) CAPB
 - D) HOXB13

Ans: B

Perez and Bradys, Principles and Practice of Radiation Oncology, 7th edition, p4878 (pdf version)

4. 下列有關 Roach equation 何者正確？
- A) Seminal vesicle involvement = $2/3 \text{ PSA} + ([\text{Gleason} - 6] \times 10)$
 - B) Lymph node involvement = $\text{PSA} + ([\text{Gleason} - 6] \times 10)$
 - C) Extracapsular extension = $1.5 \times \text{PSA} + ([\text{Gleason} - 3] \times 10)$
 - D) Roach equation 一開始是由臨床期別與三個變數共同組成

Ans: B

Perez and Bradys, Principles and Practice of Radiation Oncology, 7th edition, p4884 (pdf version)

5. 根據 Quantec 下列放射治療的劑量與副作用配對，何者不正確？
- A) 直腸, V75 < 15%, grade ≥ 2 晚期直腸毒性(late rectal toxicities) < 10%
 - B) 直腸, V50 < 50%, grade ≥ 3 晚期直腸毒性(late rectal toxicities) < 10%
 - C) 膀胱, Dmax < 65, grade ≥ 3 晚期膀胱毒性(late bladder toxicities) < 6%
 - D) 陰莖球(penile bulb), D90 < 50Gy, 嚴重勃起功能障礙(severe erectile dysfunction) < 35%

Ans: A

Gunderson & Tepper's Clinical Radiation Oncology, Fifth Edition, p1080

6. 下列敘述有關 organ motion of prostate 何者不正確？
- A) Interfraction 攝護腺位移在前後方向較側向方向大
 - B) Intrafraction 攝護腺位移在前後方向較上下方向大。
 - C) Rectal volume 與攝護腺側向位移最相關
 - D) Bladder volume 與攝護腺上下向位移相關

Ans: C

Perez and Bradys, Principles and Practice of Radiation Oncology, 7th edition, p4930 (pdf version)

7. 有關 NCCN risk group of prostate cancer，下列何者正確？

- A) T1cN0M0, PSA 11 ng/mL, GS 3+3, low risk
- B) T2cN0M0, PSA 10 ng/mL, GS 3+3, favorable intermediate
- C) T3bN0M0, PSA 9 ng/mL, GS 3+4, high risk
- D) T1cN0M0, PSA 9 ng/mL, GS 5+4, very high risk

Ans: D

Gunderson & Tepper's Clinical Radiation Oncology, Fifth Edition, p1065

8. 關於攝護腺賀爾蒙治療的下列研究，何者錯誤？

- A) RTOG 9910 證實 8 週與 28 週在放射治療前的 ADT 治療在存活率上沒有差異
- B) RTOG 9202 收錄 T2c-T4 的攝護腺癌，想要證實 4 個月與 28 個月的 ADT+EBRT 何者存活率較好
- C) TROG 96.01 證實放射治療加上 6 個月的 ADT 較 3 個月的 ADT 有更好的存活率
- D) EORTC 22961 證實放射治療加上 24 個月的 ADT 較 6 個月的 ADT 有更好的存活率

Ans: D

Perez and Bradys, Principles and Practice of Radiation Oncology, 7th edition, p5042-5045 (pdf version)

9. 有關 GETUG-01 下列何者正確？

- A) 收錄 T1b-T3N0 的案例
- B) 照射區域隨機分配至 prostate only 或是 whole pelvis field
- C) whole pelvis field 大於 RTOG 9413
- D) 兩個 randomized 的 primary endpoint 在 10-yr OS or EFS 沒有差別

Ans: C

Perez and Bradys, Principles and Practice of Radiation Oncology, 7th edition, p5022 (pdf version)

10. 下列有關 RTOG 9202 何者錯誤？

- A) 收錄 1000 多個 T2c-T4，PSA < 150 ng/mL 的案例
- B) 兩組隨機分派至 65-70Gy + 4 months ADT 與 65-70Gy + 28 months ADT
- C) 長期 ADT 使 biochemical failure rate 從 68%減少至 52%，但在 cancer specific survival 未達到統計學意義
- D) 長期 ADT 在 GS 8-10 的組別，增加 10 年總存活率

Ans: C

Perez and Bradys, Principles and Practice of Radiation Oncology, 7th edition, p5042 (pdf version)